Université de Bejaia
Faculté de Médecine
Troisième année Médecine
UE1

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

faculté de médecine de béjaia

Sémiologie Générale : les déshydratations Les Œdèmes

Dr. Terra. O, Service de Médecine interne, CHU Bejaia

Rappel physiologique

l'eau représente 60 % du poids du corps :

- 40 % dans le secteur intracellulaire
- 20 % dans le secteur extracellulaire

- **Le secteur extracellulaire** comprend lui-même le secteur interstitiel (15 %) et le secteur vasculaire (eau plasmatique 5 %).

Les liquides corporels

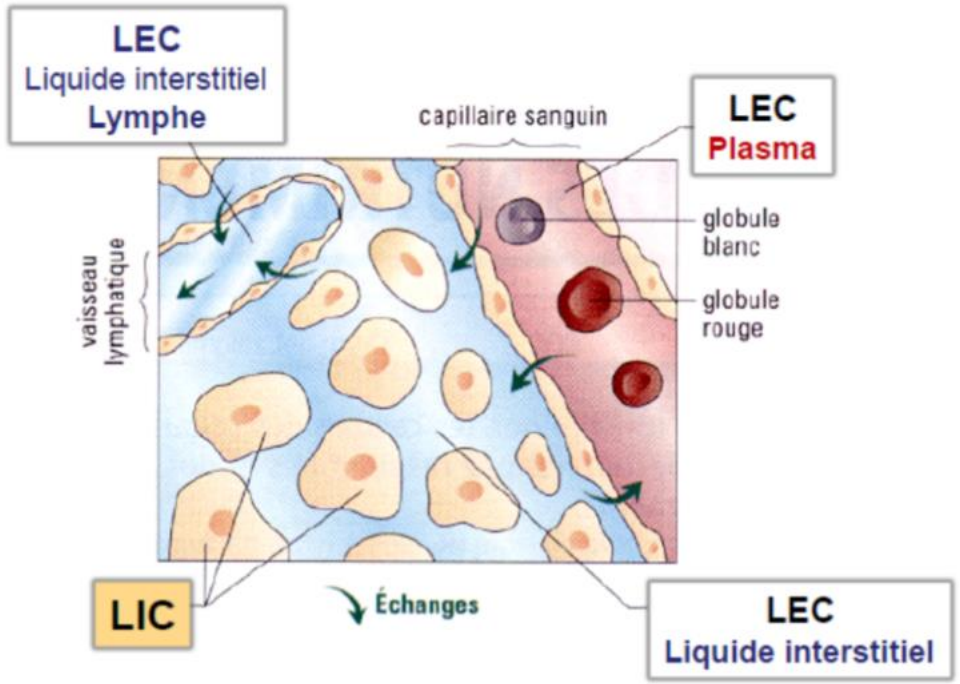
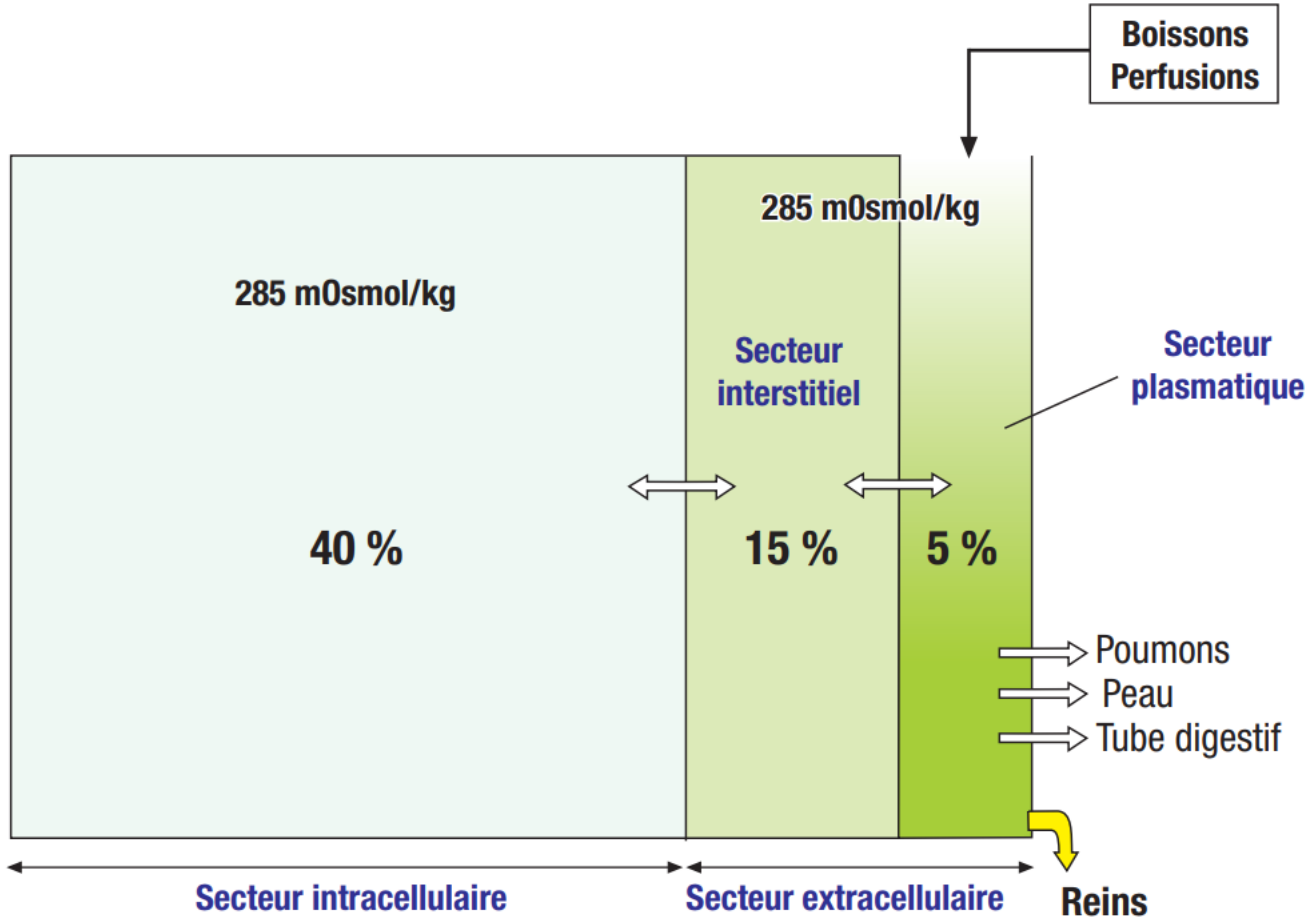


Figure N°2 : les compartiments liquidiens

LEC : liquide extracellulaire
LIC : liquide intracellulaire


Boissons
Perfusions
285 mOsmol/kg
285 mOsmol/kg
Secteur
interstitiel
Secteur
plasmatique
40 %
15 %
5 %
Poumons
Peau
Tube digestif
Secteur intracellulaire
Secteur extracellulaire
Reins

1. Les déplacements liquidiens :

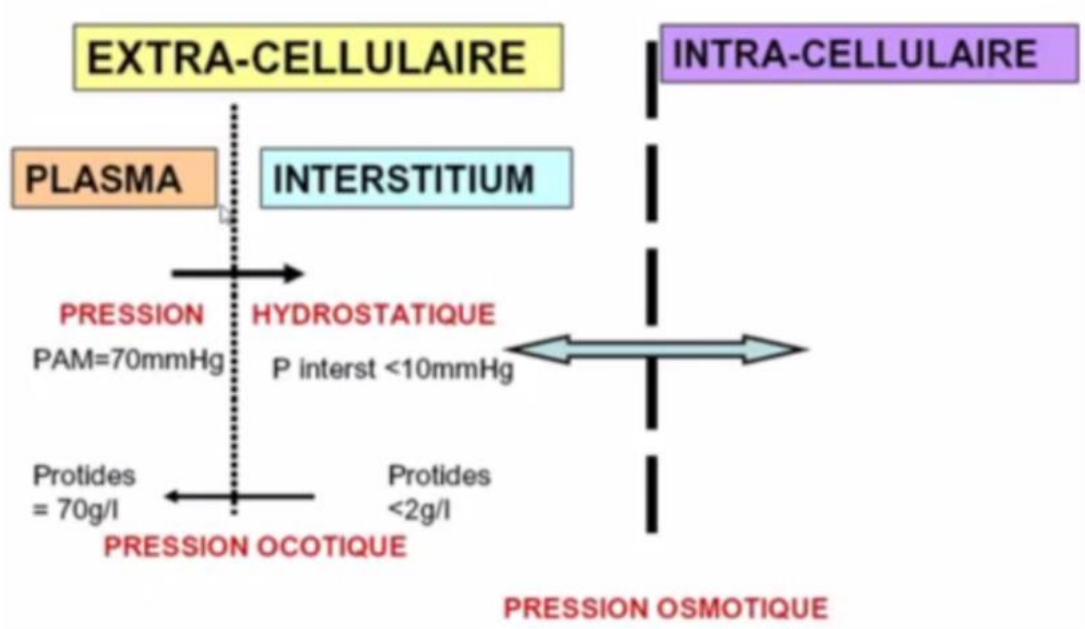


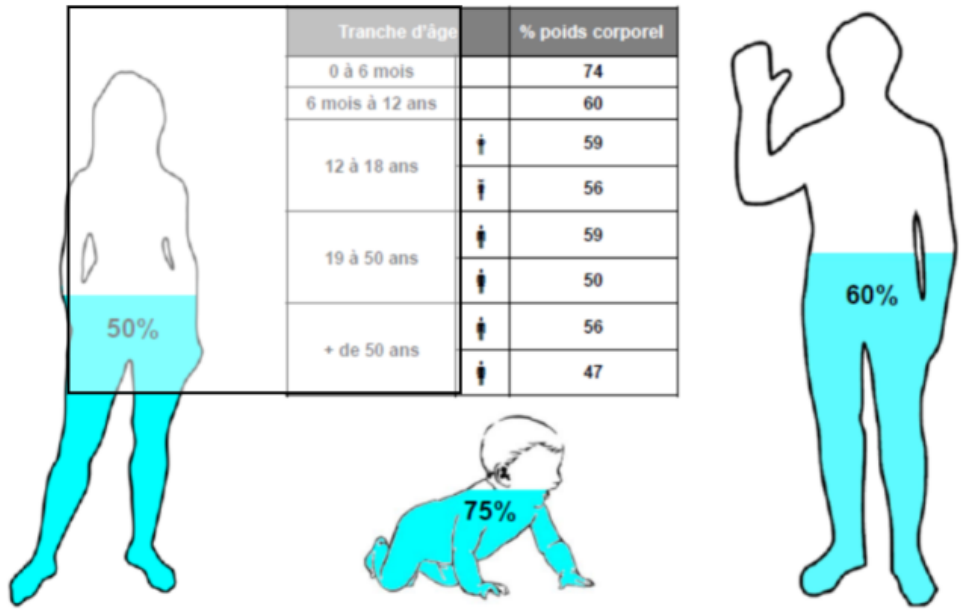
Figure N°7 : Les déplacements liquidiens entre les secteurs

Rappel physiologique

- La teneur en eau est plus faible chez la femme
- elle diminue avec l'âge
- Elle peut atteindre jusqu'à 75 % chez le nourrisson

Composition des liquides corporels

Contenu corporel en eau



Tranche d'âge		% poids corporel
0 à 6 mois		74
6 mois à 12 ans		60
12 à 18 ans	♂	59
	♀	56
19 à 50 ans	♂	59
	♀	50
+ de 50 ans	♂	56
	♀	47

Figure N°1 : Composition en eau selon l'âge et genre

Toute augmentation en teneur d’eau et/ou de sodium dans l’organisme

Va entrainer un état d’hyperhydratation

Toute diminution d’eau et/ou de sodium dans l’organisme

Entrainera un état de déshydratation

Les Déshydratations



Définition

La déshydratation est une diminution d'installation aigue,
du secteur Extracellulaire ou du Secteur intracellulaire
en rapport avec un bilan négatif en eau et/ou de sodium

- La déshydratation est **diminution d'installation aigue**, du secteur Extracellulaire ou du Secteur intracellulaire en rapport avec un **bilan négatif en eau et/ou sodium**

- Elle sera **plus rapide et plus grave chez les nourrissons et les sujets âgés**

- La recherche d'une déshydratation est systématique dans ces populations à risque
  Par l'examen clinique en cas de situation favorisante ex : diarrhée aigue

Déshydratation extracellulaire

Déshydratation extracellulaire

La déshydratation extracellulaire est en rapport avec une
perte d'eau et de sodium, au dépend du secteur extracellulaire (plasmatique et interstitiel)
pouvant s'accompagnant d'une hypovolémie

Déshydratation extracellulaire

Sémiologie :

- Perte de l'élasticité de la peau (pli de déshydratation)
- Hypotonie des globes oculaire (enfoncés dans l'orbite)
- Perte de poids rapide

Déshydratation extracellulaire

Sémiologie :

Signes d'hypovolémie :

- Hypotension artérielle
- Hypotension orthostatique (lors de passage en position debout)
- Tachycardie
- Vertiges
- Oligurie : diminution de la diurèse

Déshydratation extracellulaire

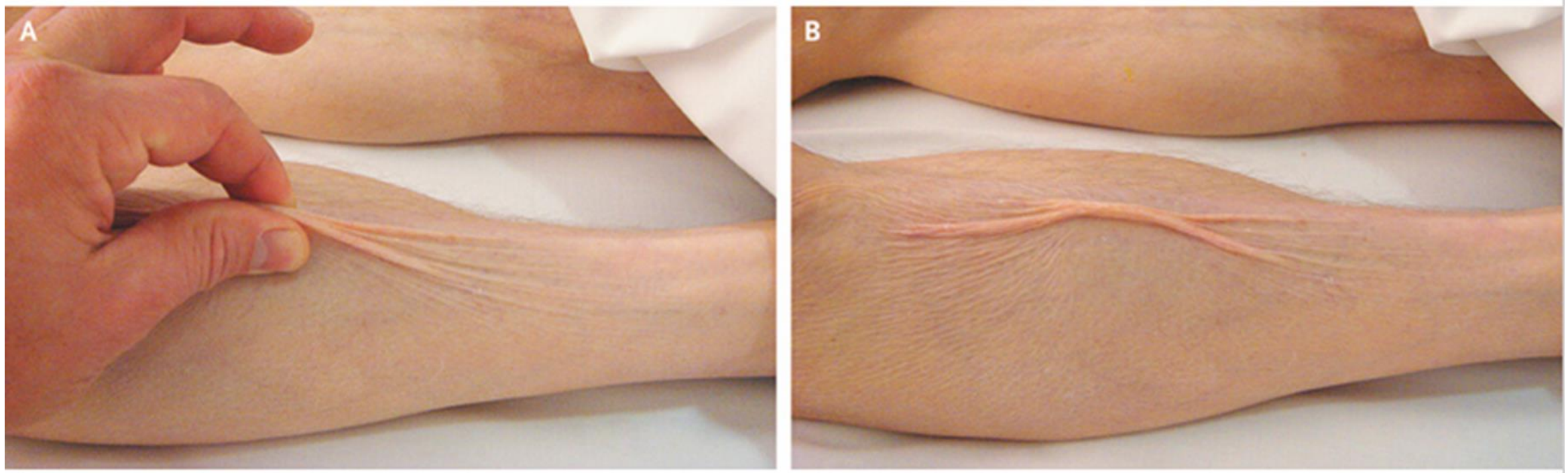
Sémiologie : le pli cutané

- Le pli cutané est du à la perte de l'élasticité cutanée,
la peau pincée entre le doigt et l'index va garder le pli

- Il est recherché au niveau de :
  - La région sous claviculaire, prés du sternum
  - La face interne de la cuisse

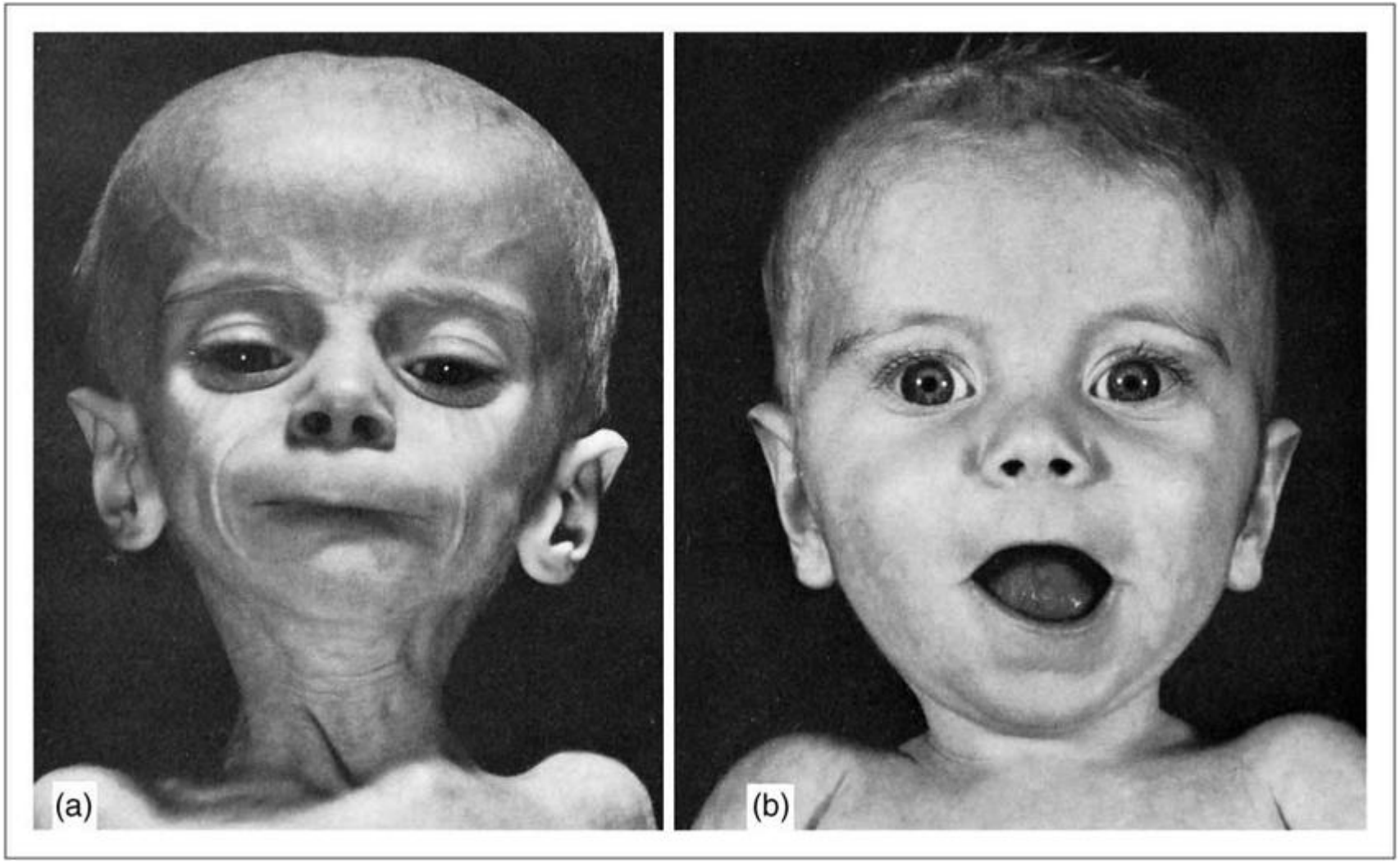
Chez le sujet âgé ou ne cas de dénutrition, il est habituel de retrouver un pli
Sous claviculaire, il convient de le rechercher au niveau des cuisses (face interne)

The New England Journal of Medicine



Decreased Skin Turgor | New England Journal of Medicine

Pli cutané



Hypotonie des globes oculaires lors d’une déshydratation sévère (a), noter le retour à un aspect normal après correction de la déshydratation (b)





Bien pincer la peau et le tissu sous cutané
pour chercher le pli de déshydratation







Déshydratation extracellulaire

Signes de gravité :

C’est les signes de choc hypovolémique :

Signes d’hypoperfusion tissulaire

- Hypotension artérielle sévère
- Troubles de la conscience
- Extrémités froides
- Marbrures : coloration violacée de la peau liées à l’hypoperfusion
- Oligo-anurie (diminution marquée voir absence de diurèse)

Déshydratation extracellulaire

Principales causes :

Pertes digestives :

- Diarrhées profuses
- Vomissements prolongés
- Abus de laxatifs
- Fistules digestives (communication pathologique complexe entre deux organes)

Cutanées :

- Fièvre prolongée (Hypersudation)
- Exercice physique intense (hypersudation)
- Dermatose cutanée étendue (pertes cutanée de protéines = exsudation)
- Brûlures étendues

Déshydratation extracellulaire

Principales causes :

Pertes rénales :

- Certaines Néphropathies chroniques (interstitielles)
- Hypercalcémie
- Polyurie osmotique (diabète décompensé)
- Utilisation prolongée de diurétiques
- Insuffisance surrénalienne

Troisième secteur :

(compartiment liquidien qui se forme brutalement aux dépend du secteur extracellulaire)

Exemple: liquide au niveau du péritoine au cours de certaines urgences digestives :

- Pancréatite aigue
- Péritonite
- Occlusion intestinale aigue

Déshydratation intracellulaire

Déshydratation intracellulaire

La déshydratation intracellulaire est en rapport avec un **déficit hydrique** qui est une liée à un une **hyperosmolarité plasmatique** responsable d'un passage de l'eau du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire

Il existe obligatoirement une Hyperosmolarité plasmatique +++

- **L’hyperosmolarité est en rapport avec un déficit en eau**
- La stimulation rapide et intense de la **soif** est un mécanisme qui permet de compenser et rétablir l’état d’hydratation
- C’est un état grave qui peut entrainer le décès en l’absence de prise en charge
- Moins fréquente que la déshydratation extracellulaire

Les sujet les plus **à risque** à faire une déshydrations intracellulaire sont les sujets dont L'apport en eau libre est impossible ou il y a un dysfonctionnement des centres de la soif

- Sujet en institution
- Sujet âgé avec troubles mnésiques, ou vit seul (grabataire) : pas d'accès à l'eau
- Patient avec troubles de la conscience (coma) ou en réanimation
- Nourrisson
- Milieux extrêmes ex : le désert

Déshydratation intracellulaire

Sémiologie :

- Perte de poids importante.
- **Soif intense**
- Sécheresse des muqueuses qui se recherche au niveau de la muqueuse jugale (des joues) et la langue
- Polypnée
- fièvre
- Troubles de la conscience.

Déshydratation intracellulaire

Signes de gravité :

- Les trouble de la conscience
- Coma
- oligo-anurie
- L’association avec des signes de déshydratation extracellulaire

Déshydratation intracellulaire

Principales causes :

- **Diabète insipide +++** (syndrome polyuro-polydipsique au premier plan)
  - Hypophysaire central
  - néphrogénique
- Pertes respiratoires d'eau (polypnée)
- Apports excessifs en sel
- Sueurs profuses
- Diarrhée avec perte d'eau prédominante

Déshydratation Mixte

- Association possible
- On observe les signes de déshydratation intracellulaire et extracellulaire
- La perte d'eau est supérieure à celle du sel
- observée en cas de pertes digestives majeures (diarrhées profuses ex : le choléra)

La diurèse

La diurèse

- La diurèse désigne le volume de la sécrétion urinaire
- C’est le débit urinaire

La diurèse

- La diurèse normale se situe entre 800 et 1500 ml par jour
- Une diminution du débit urinaire est appelée oligurie
- Une augmentation du débit urinaire est appelée polyurie

Evaluation de la diurèse

- La quantification de la diurèse est possible à l'aide d'un dispositif de recueil (bocal)
- Parfois à l'aide d'une sonde urinaire munie d'un sac collecteur
- Quantification horaire et sur 24 heures
- Exprimée en (ml) par heure ou par 24 heure







Evaluation de la diurèse

- La polyurie correspond à une augmentation du volume urinaire supérieur à 3 litres par jour voir plus

- Quand la polyurie est associée à une soif implorante avec prise d'eau en parle de syndrome polyuro-polydipsique (polyurie-polydipsie)

Evaluation de la diurèse

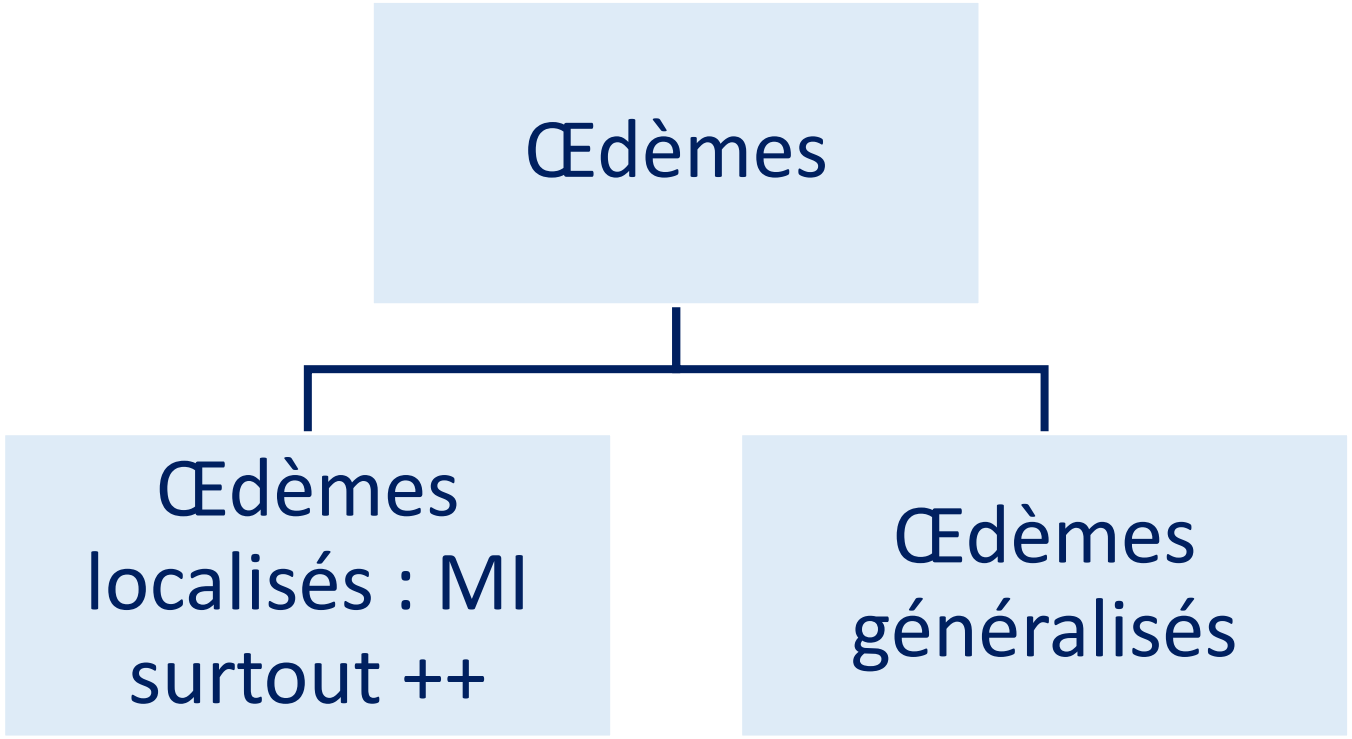
- Une oligurie correspond à une diminution du volume urinaire sur 24 heures
- On parle d'oligurie quand la diurèse est inférieure à 400 ml/24h
- On parle d'anurie quand la diurèse est inférieure à 100 ml/24h
- **Attention à la rétention d'urines qui n'est pas une anurie, c'est un blocage à la miction**
  Lié à un obstacle anatomique généralement prostatique : à éliminer systématiquement en cas l'oligo-anurie

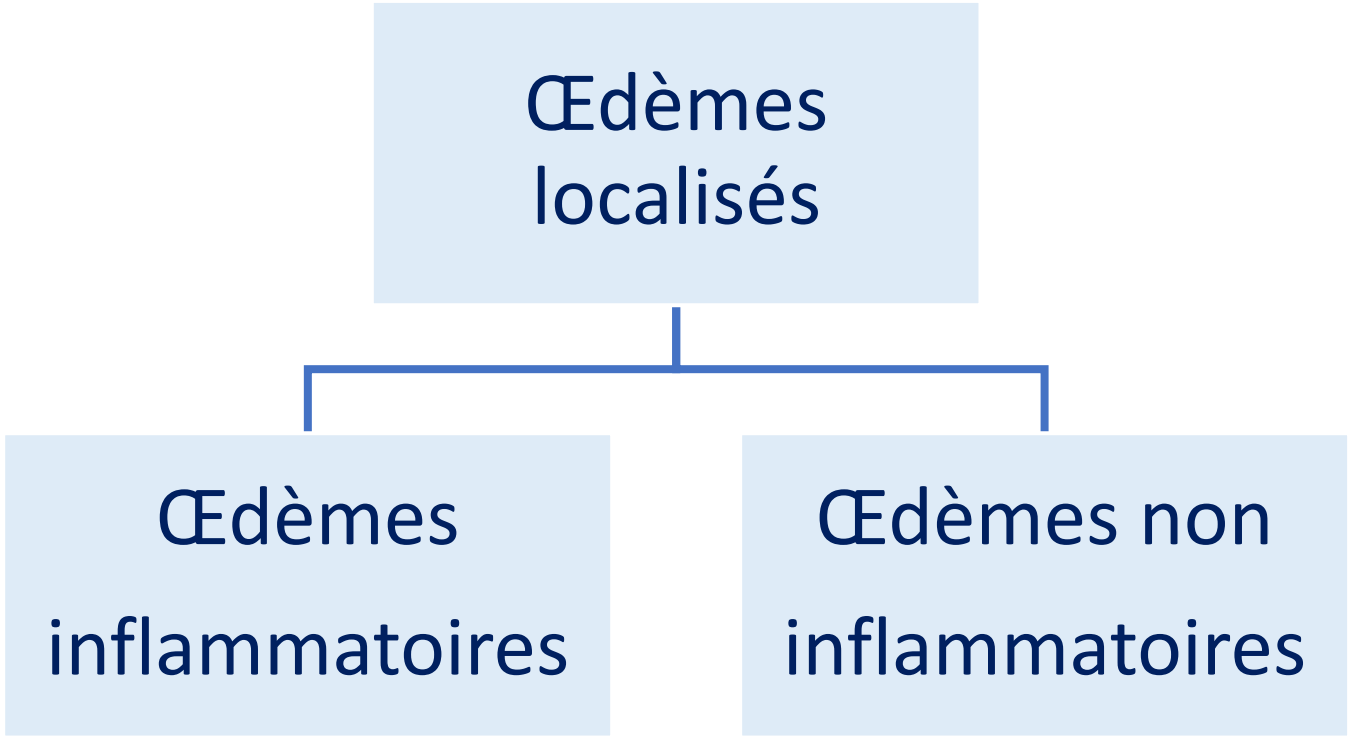
Sémiologie des Œdèmes (état d’hyperhydratation)

Définition

L’ œdème correspond à une accumulation de liquide dans le secteur interstitiel

Il peuvent être localisés ou généralisés


Œdèmes
Œdèmes localisés : MI surtout ++
Œdèmes généralisés


Œdèmes localisés
Œdèmes inflammatoires
Œdèmes non inflammatoires

Physiopathologie des Œdèmes :

Les œdèmes relèvent de 4 mécanismes principaux souvent intriqués :

- Augmentation de pression hydrostatique
- Diminution de la pression oncotique (liée aux protéines plasmatiques)
- Augmentation de la perméabilité capillaire
- Diminution de résorption lymphatique

Sémiologie des Œdèmes

- prise de poids isolée
- augmentation du volume des membres inférieurs
- Localisation déclive : cheville, face antéro-externe du tibia
  - unilatérale ou bilatérale
  - localisée ou diffuse

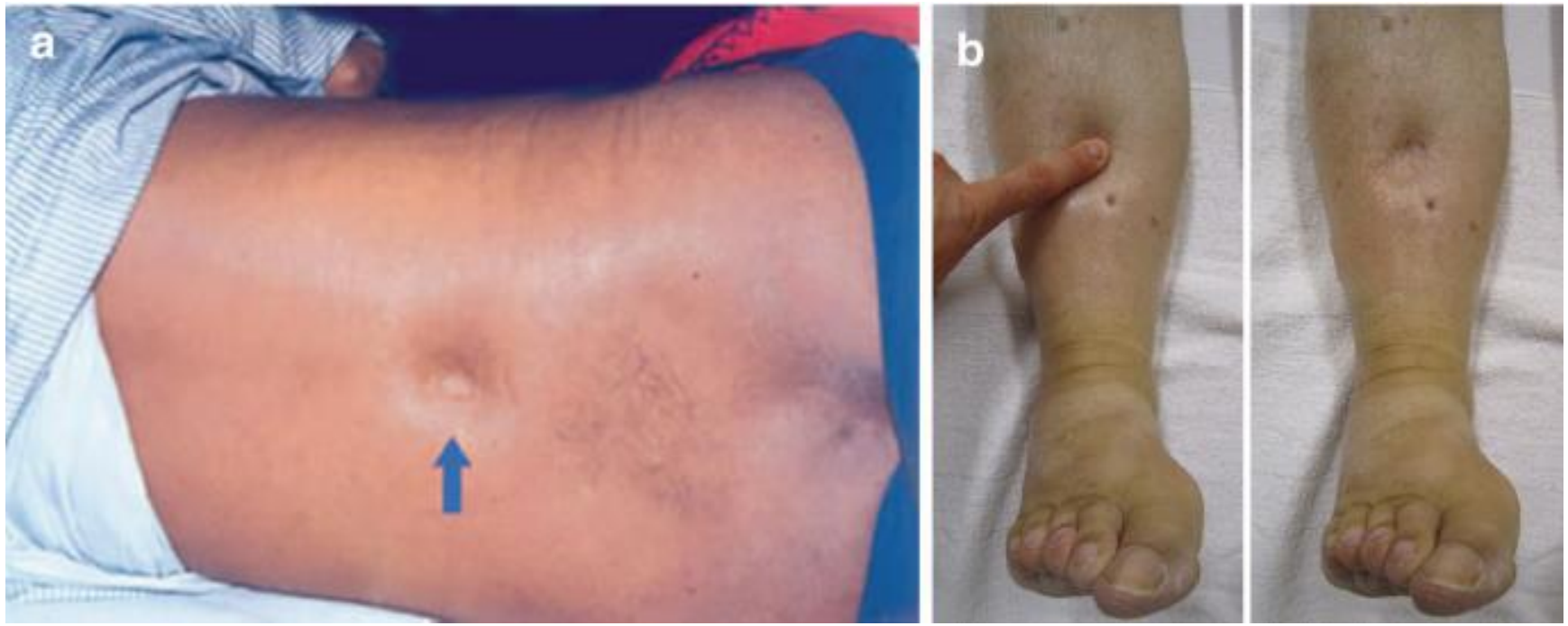
Sémiologie des Œdèmes

- effacement des reliefs osseux ou musculaire
- consistance ferme ou molle (prenant le godet)
- Douloureux ou non



Le signe du godet

La pression par le pouce de l'œdème laisse une dépression visible
à rechercher au niveau des membres inférieurs ou dans la région lombaire chez le malade en décubitus dorsal (allongé sur le dos) ou alité



interrogatoire

Le terrain :

- ATCD médico-chirurgicaux
- ATCD personnels de cardiopathie
- ATCD d’hépatopathies chronique
- ATCD de maladie rénale chronique
- Prises médicamenteuses



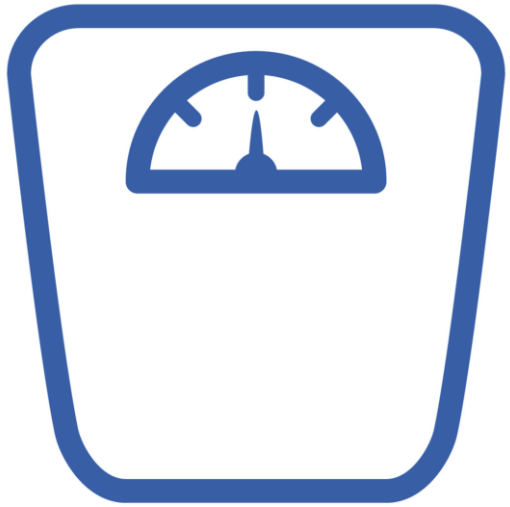
interrogatoire

- Mode d’apparition : aigu, progressif
- Ancienneté des symptômes
- Caractère permanent , intermittent
- Caractère déclive
- Douloureux ou non
- Signes accompagnateurs

Examen clinique

Examen général :

- Poids +++
- Pression artérielle
- fréquence cardiaque
- Diurèse des 24h
- Altération de l’état général





Examen clinique

Les œdèmes:

- Caractère uni ou bilatéral
- Caractère ferme ou non (évolution prolongée)
- signe du godet
- Chaleur locale et modifications cutanées (caractère inflammatoire)
- Déclives : rétention hydrosodée (œdèmes généralisées)

Autres localisations des oedèmes :

- Région lombosacrée
- Visage
- Paupières
- Testicules ….

Les Œdèmes localisés : Membres inférieurs

Principales causes :

- Thrombose veineuse profonde
- Insuffisance veineuse
- Syndrome post-thrombotique ou post-phlébitique
- Lymphœdèmes
- Erysipèle (inflammation d'origine bactérienne sous-cutanée
- Fasciite (infection bactérienne sous-cutanée extensive atteignant le fascia



Thrombose veineuse profonde



Insuffisance veineuse



Syndrome post-thrombotique





lymphœdèmes



érysipèle



fasciite

Anasarque

- Association parfois à des épanchements (accumulation de liquide) au niveau des séreuses **(anasarque)**
    - **Ascite** (épanchement liquidien au niveau du péritoine)
    - **Épanchement pleural** (épanchement liquidien au niveau de la plèvre)
    - **Épanchement péricardique** (épanchement liquidien au niveau du péricarde)

Principales Causes des Œdèmes généralisés

Causes Cardiaques :

- Insuffisance cardiaque droite
- Insuffisance cardiaque gauche

Causes Rénales :

- Syndrome néphrotique

Causes digestives :

- Cirrhose
- Malabsorption
- Entéropathies exsudatives (perte de protéines par le tube digestive)

Caractéristiques Sémiologiques

Œdèmes d'origine cardiaque

- Blanc, parfois rouges
- Douloureux parfois
- Signe du godet inconstant

Œdèmes d'origine rénale

- Blancs
- Mous
- Gardant le godet

Caractéristiques Sémiologiques

Œdèmes anciens

- Fermes
- Signe du godet inconstant

Merci pour votre attention